

Biopsie cutanée

2 questions à se poser

1. L'indication est-elle pertinente ?

= aurai-je la réponse à la question ?

2. Où biopsier ?

= quelle lésion va m'apporter l'information ?

Choix du site

- **Pathologie inflammatoire NON bulleuse**: lésion récente et non remaniée
- **Pathologie bulleuse**: à cheval peau saine et peau décollée
- **Pathologie tumorale**: zoné lésionnelle

Déroulement

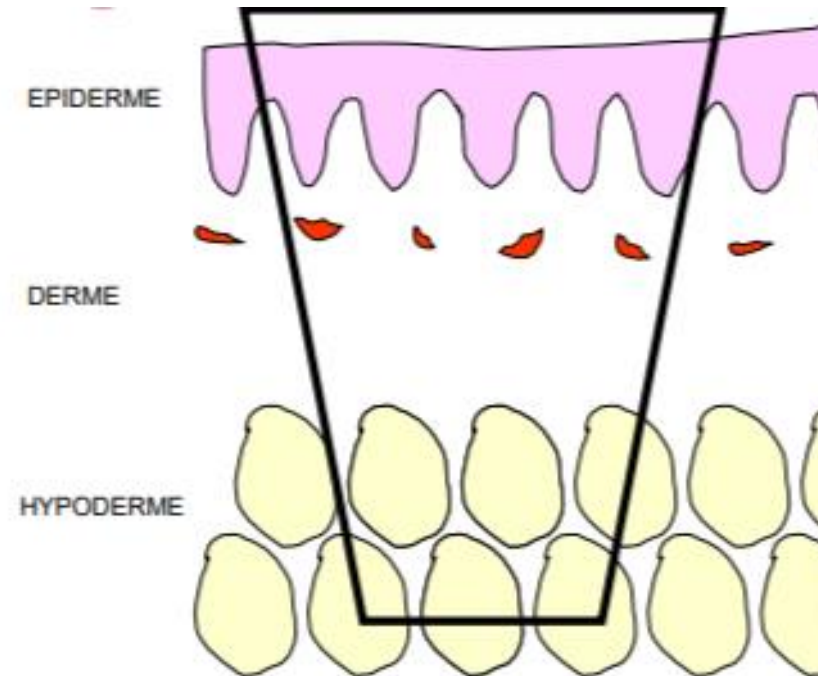
- Expliquer au patient +++
- Lavage des mains
- Port de gants (non stériles)
- Désinfection locale
- Injection hypodermique
- Lidocaïne 0.5, 1, 2% +/- adrénaline



Biopsie

- Soit au punch: lame cylindrique
- Soit au bistouri
 - pour des prélèvement + gros
 - pour l'hypoderme

On n'oublie pas de suturer



Conservation

- **Histologie standard :**

- Formol 10%

- **IFD:**

- Compresse stérile imbibée de sérum physiologique avant congélation dans de l'azote liquide

- Liquide de Michel

Service d'Anatomo-Cyto-Pathologie et de Neuropathologie Pr. FIGARELLA-BRANGER - Hôpital de la TIMONE/BMT 264 Rue Saint Pierre - 13385 Marseille cedex 05 Secrétariat 04 13 42 90 10 - Fax. 04 13 42 90 42 Horaires d'ouverture : Lundi au Vendredi de 7h00 à 16h30		
BON DE DEMANDE D'EXAMEN ANATOMO-CYTO-PATHOLOGIQUE (Utiliser le bon dédié : pour un fœtus ou un placenta réf: MMF048, pour une autopsie réf: MMF049)		
Ne pas remplir les cases grisées : réservées au service		
Service et UF Demandeur Tél. : _____	Patient NOM marital : _____ NOM de jeune fille : _____ Prénom : _____ Date de naissance : ____ / ____ / ____ Sexe : H ☐ F ☐ N° Hospitalisation : _____	Numéro de travail
Médecin (s) prescripteur (s) (obligatoire) Nom, Prénom : _____ Tél. : _____ Signature : _____	Préleveur (si différent du prescripteur) Tél. : _____ Signature : _____	Horodateur réception
Date de prélèvement : _____	Heures de prélèvement : _____ de fixation : _____	
☐ Frais : ☐ Examen Extemporané ☐ Autre : _____ Heure de fixation dans le service d'ACP : _____	☐ Fixé : ☐ Formol ☐ Glutaraldehyde (ME) ☐ Liquide de Michel (IF)	
☐ Cytologie : nb lames : _____ nb tubes/pots : _____	☐ Biopsie ☐ Pièce opératoire	Nb total de pots : _____
Renseignements cliniques et hypothèses diagnostiques : 		
Nature et siège du (des) prélèvement(s) : 		
➔		
Déposant : _____	Technicien de réception : _____	
☐ Refusé ☐ Accepté		

Ne jamais laisser seul un prélèvement à la réception. S'il n'y a personne, appelez le secteur paraffine au 04.13.42.90.33

Lésions épidermiques

Acanthose : épaissement de tout ou partie (crêtes) de l'épiderme

Acantholyse : perte de cohésion des kératinocytes par rupture des desmosomes, aboutissant à la constitution de fentes ou de bulles intra-épidermiques.

Atrophie : amincissement global de l'épiderme par diminution du nombre de couches cellulaires.

Epidermotropisme : migration de cellules tumorales dans l'épiderme.

Exocytose : migration de cellules inflammatoires dans l'épiderme.

Hypergranulose : épaissement de la couche granuleuse.

Hyperkératose : épaissement de la couche cornée.

Nécrose kératinocytaire : mort cellulaire avec aspect d'apoptose ou de vacuolisation.

Papillomatose : accentuation du dessin des papilles et des crêtes inter-papillaires.

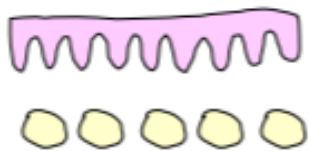
Parakératose : Persistance de structures nucléaires dans les cornéocytes.

Pustule : conséquence d'une spongiose avec polynucléaires neutrophiles ou éosinophiles. Peut-être uniloculaire (une cavité) ou multiloculaire (plusieurs cavités).

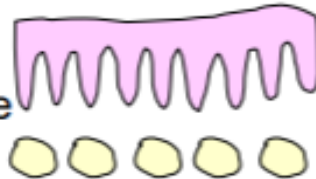
Spongiose : Œdème intercellulaire

Vésicule : cavité formée par la confluence de zones spongiotiques.

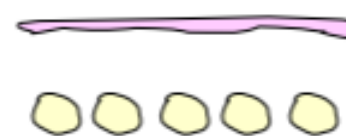
Epiderme
normal



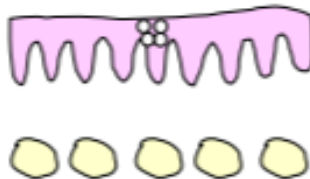
Acanthose et
Papillomatose



Atrophie



Spongiose/
Vésicule/
Pustule



Lésions dermo-épidermiques

Modèle Psoriasiforme : Allongement parallèle et régulier des papilles dermiques, dont le toit est aminci. Inflammation surtout dans les papilles avec exocytose en regard. Exemple : psoriasis

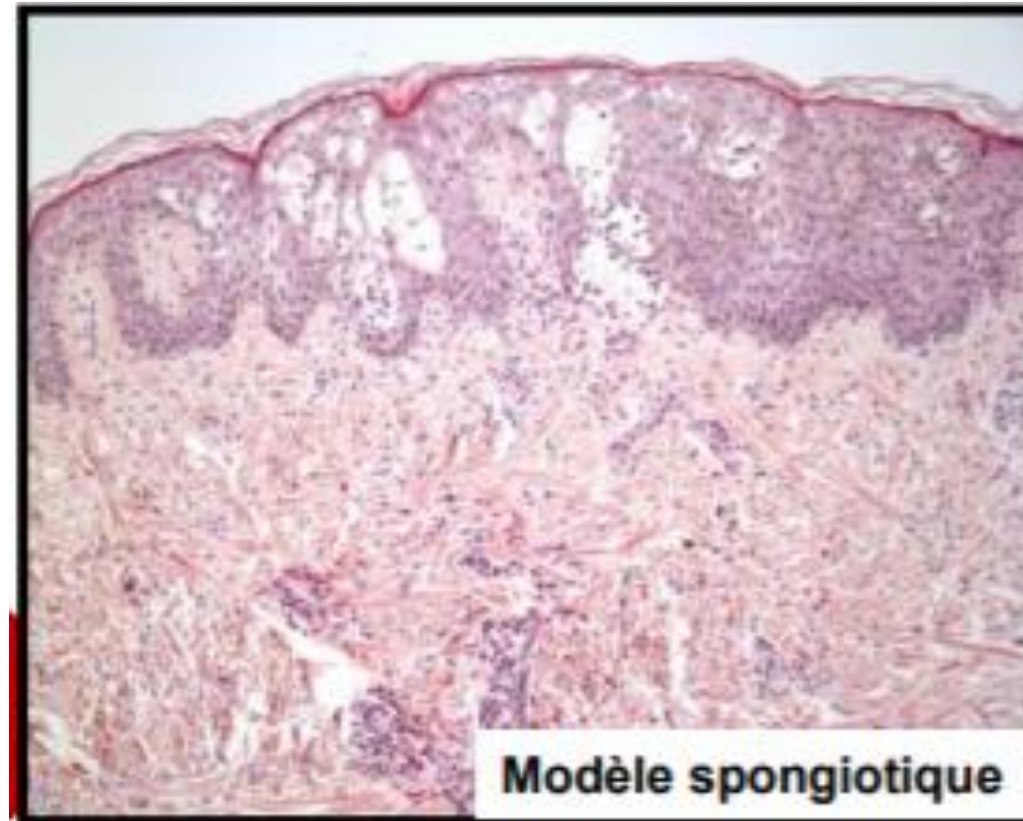


Modèle psoriasiforme

Lésions dermo-épidermiques

Modèle Spongiotique : Œdème des papilles avec inflammation du derme superficiel et exocytose.

Exemple : eczéma, dermite seborrhéique...

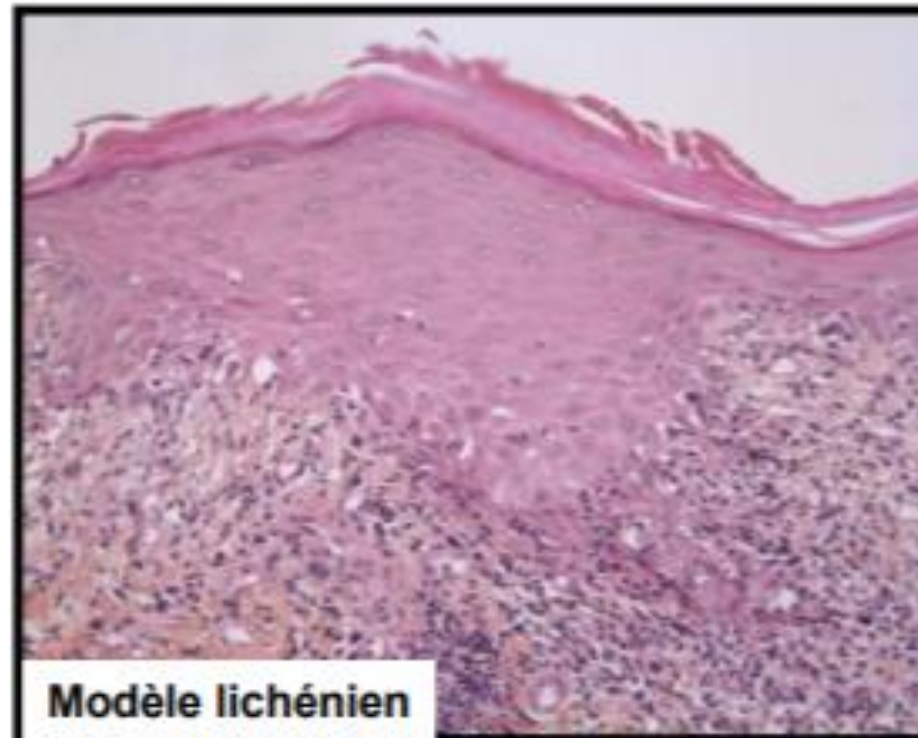


Modèle spongiotique

Lésions dermo-épidermiques

Modèle Lichénoïde : Appelé également « dermite d'interface ». Vacuolisation et/ou nécrose des kératinocytes basaux, infiltrat sous épidermique avec exocytose basale, aspect basale « grignotée ».

Exemple : lichen plan, toxidermies lichénoïdes, GVH, lupus...



Modèle lichénien

Lésions dermo-épidermiques

Modèle de la Bulle sous-épidermique : Décollement de la jonction dermo-épidermique avec infiltrat inflammatoire dont la nature oriente parfois vers un diagnostic.

Exemple : dermatoses bulleuses auto-immunes (pemphigoïde bulleuse), toxidermie bulleuse....



Modèle Bulleux

Lésions dermiques

Atrophie dermique : diminution d'épaisseur du derme et raréfaction des fibres de collagène.

Elastolyse : disparition des fibres élastiques.

Elastose (dite sénile) : modifications du collagène liées à l'action des UV.

Incontinence Pigmentaire : présence de mélanine dans le derme superficiel (libre ou dans des mélanophages).

Infiltrats cellulaires : présence de cellules inflammatoires ou tumorales dans le derme.

Œdème dermique : pâleur du derme secondaire à la présence de liquide interstitiel.

Nécrobiose : altération des fibres de collagène devenant éosinophiles et amorphes.

Sclérose dermique : épaissement des fibres de collagène pouvant prendre un aspect hyalin.

Lésions hypodermiques

Adiponécrose : nécrose des adipocytes conduisant à des images de membranes et kystes.

Atrophie hypodermique.

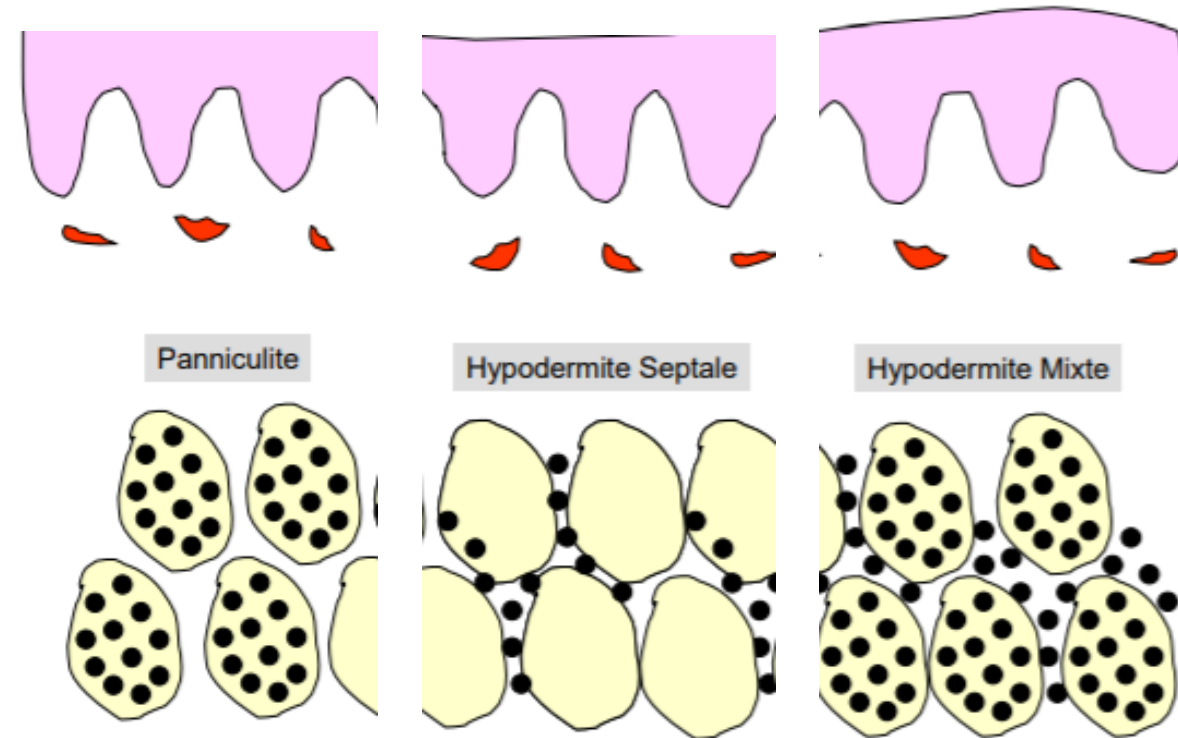
Lipophagie : résorption graisseuse par des histiocytes-macrophages conduisant à leur aspect spumeux.

Inflammation de l'hypoderme :

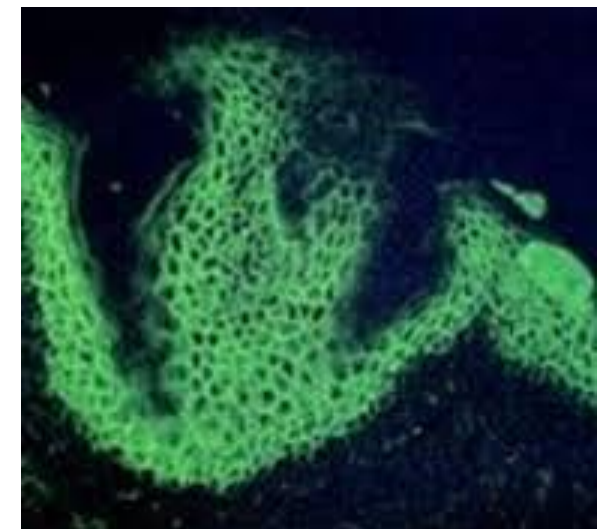
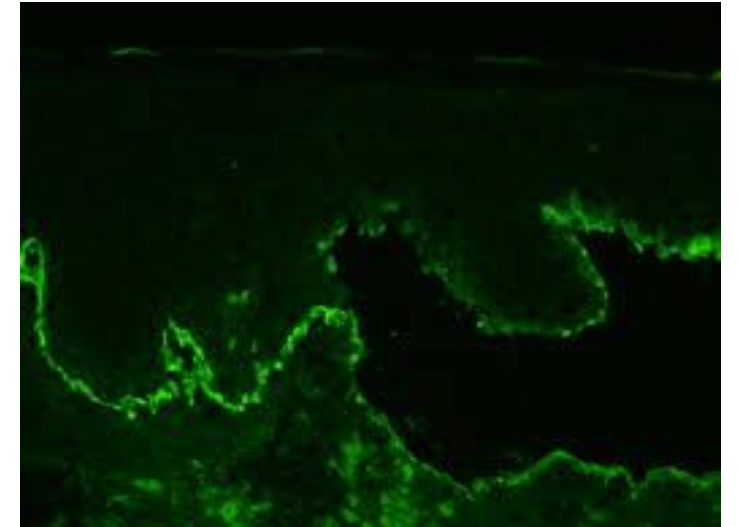
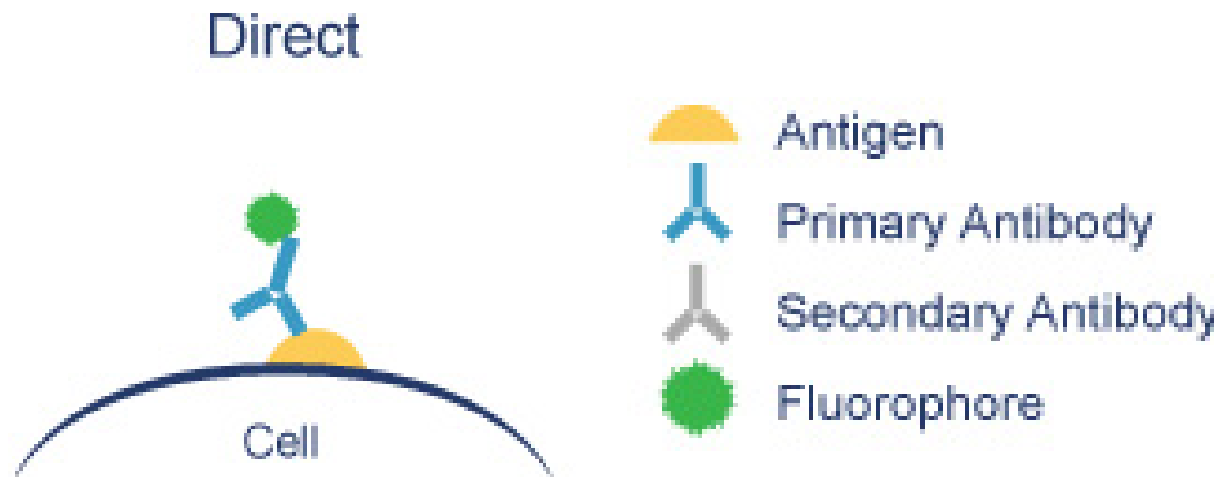
Panniculites lobulaires (ou panniculite vraie): inflammation primitive des lobules adipeux.

Hypodermites septales : inflammation localisée aux septas.

Hypodermites mixtes : inflammation lobulaire et septale.

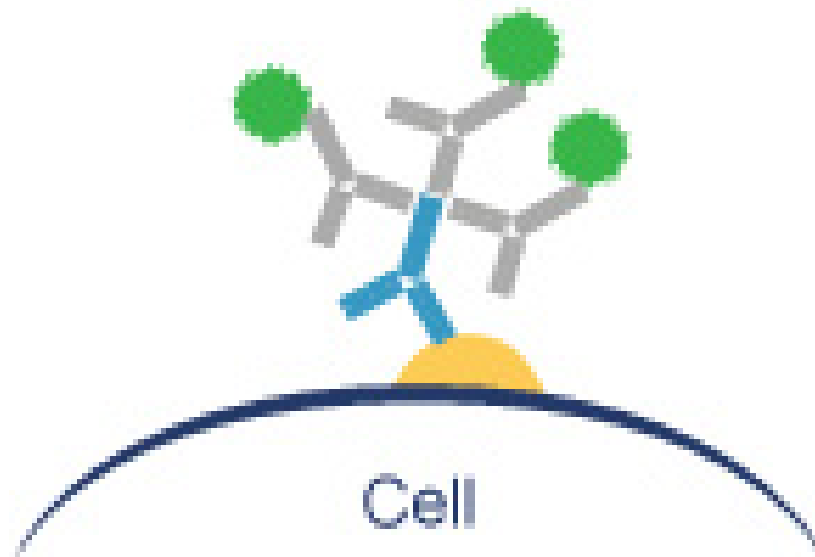


Immunofluorescence directe



Immunofluorescence indirecte

Indirect



-  Antigen
-  Primary Antibody
-  Secondary Antibody
-  Fluorophore